

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 1 de 25

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAU

Elaborado por: Matr. Daniela Saravia N TENS Catherine Cáceres	Revisado por: Matr. Nataly Cortés F	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas Espinoza
Unidad: Matrona y TENS Sector Urbano	Unidad: Matrona Encargada Programa Cacu	Unidad: Director CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
Fecha: 20-04-2026	Fecha: 27-04-2026	Fecha: 28-04-2026
Firma: Daniela Saravia N. Matrona Ecografista Rut 17.291.509-4   Catherine Cáceres Pérez Rut: 15.802.881-6	Firma: Nataly Cortés Farfaj MATRONA RUT: 16.214.826-4 	Firma:  

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 2 de 25

I. INTRODUCCIÓN.

Dentro de los estándares de acreditación de atención abierta se exige que los establecimientos de salud aseguren la trazabilidad de muestras de biopsias y citologías realizadas a usuarios/as, considerando que el análisis oportuno y seguro proporciona un elemento importante para diagnósticos y tratamientos. La responsabilidad del equipo de salud en el manejo de las muestras durante todo el proceso, desde que se obtienen hasta la recepción del informe de resultado y su registro en ficha clínica, requiere de la total seguridad de que pertenezca al usuario/a original, puesto que errores durante cualquier etapa del proceso pueden tener consecuencias graves para el paciente. Por la importancia que reviste todo este proceso es indispensable contar con un documento que permita la unificación de los criterios desde la obtención, registro, traslado y entrega de resultados, entre el personal de salud clínico y administrativo que participa en esta actividad.

II. PROPÓSITO

Estandarizar el procedimiento de toma de muestra, rotulación, registros, traslado, recepción de muestras y rechazos de citología exfoliativa de cuello uterino o Papanicolaou (PAP).

III. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Establecer el procedimiento de toma de muestra, rotulación, registros, traslado y recepción de citología exfoliativa de cuello uterino o PAP en CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas de Salud Rurales de la Comuna de Peralillo.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 3 de 25

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un sistema de manejo de muestras que permita su trazabilidad, desde la toma del examen, entrega del análisis de resultado a la usuaria hasta la evolución clínica de éste en el establecimiento.
- Velar por el traslado de las muestras de PAP desde el establecimiento de salud responsable de la toma a la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Regional Franco Ravera Zunino, en las condiciones y plazos establecidos en el presente protocolo.
- Evaluar sistemáticamente los procesos preanalíticos de toma de muestras PAP a nivel institucional.

IV. ALCANCE

Aplica a todos los funcionarios/as que tengan injerencia directa o indirecta en el procedimiento de toma, rotulación, registros, traslado, recepción y resultado de citología exfoliativa de cuello uterino.

V. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **Matrón/a:** Tomar muestra; completar de manera clara, legible y completa la muestra y hoja SEC, resguardar las muestras hasta entregar a TENS a cargo de consolidar nomina para envío UAP. En caso de ausencia de TENS deberá notificar los resultados de PAP normales a las usuarias registrando además en ficha clínica del paciente.
- **Encargado local Programa prevención CaCu:** Recepcionar, registrar los resultados de análisis citológicos con prioridad en los alterados, notificar resultados con prioridad en los alterados y derivar de forma oportuna a otros niveles de atención según corresponda en concordancia con Guía Clínica

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 4 de 25

Cáncer Cérvicouterino MINSAL 2015 y decreto GES vigente. Velar por el cumplimiento de traslado de muestras desde el establecimiento a UAP del HRFRZ en condiciones y plazos establecidos. Diseñar, ejecutar e informar planes de mejora a Encargada de Programa Prevención CaCu de Dirección Servicio de Salud. Evaluar periódicamente los planes de mejora implementados con el objeto de determinar el cumplimiento de estos.

- **TENS de Apoyo Matronas:** Elaboración de registros; preparación y embalaje de muestras cotejando que los datos sean coincidentes y que las muestras vayan debidamente protegidas; envío de muestras de PAP; recepción de los resultados; realizar nómina de PAP, gestiona el envío de las muestras a Unidad de anatomía patológica del HRFRZ, entrega de nómina a digitadora SIGGES. Recibe recepción conforme de muestras entregadas y muestras rechazadas. Informa a Encargada Programa CaCu del establecimiento el detalle de muestras rechazadas. Notificar los resultados de PAP normales a las usuarias registrando además en ficha clínica del paciente. Completar registro interno para Unidad SIGGES.
- **Jefe movilización:** Recepcionar muestras y entregarlas al conductor o estafeta designado para el envío de la muestra hacia HRFRZ.
- **Conductores/Estafeta:** Entregar muestras sin deterioros de embalaje desde CESFAM a Unidad Anatomía Patológica en HRFRZ.
- **Digitadora GES:** Recepcionar nómina de PAP para crear el caso GES (Al recepcionar los resultados de las muestras de PAP con resultado negativo se cierra el caso y al ser positivos se continúa la prestación).

VI. DEFINICIONES

Citología exfoliativa: Remoción de células para ser examinadas macro y microscópicamente con la finalidad de formular un diagnóstico.

Cacu: Cáncer Cérvico uterino.

PAP: Entendido como el “Examen de Papanicolau” o Citología exfoliativa.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 5 de 25

CITO-Fijador: Líquido fijador en spray que permite fijar y conservar la muestra extraída del cuello del útero de forma indefinida.

Espátula de Ayre: Espátula de madera inastillable para la toma de PAP.

Trazabilidad: Seguimiento de un producto. En este caso muestra de citología exfoliativa, que permite conocer la ubicación y la trayectoria durante el proceso, desde la fase pre-analítica hasta la entrega del resultado a la usuaria y evolución clínica.

Sistema de registro de PAP: Herramienta utilizada para el control de registro de los exámenes de Papanicolaou.

SIGGES: Sistema de información para la gestión de Garantías Explícitas en Salud.

GES: Garantías Explícitas en Salud.

HRFRZ: Hospital Regional Franco Ravera Zunino

UAP: Unidad de Anatomía Patológica.

SEC: Solicitud de Examen Citológico.

NIE: Neoplasia Intraepitelial.

FUR: Fecha de Última Regla.

VII. DESARROLLO DEL PROCESO

1. CRITERIOS GENERALES.

El presente documento describe la trazabilidad en la toma de PAP desde las condiciones previas para la toma de muestra hasta los informes de recepción de resultados (etapa pos analítica)

1.1. Condiciones para la toma de muestra de citología cervical.

Si bien no existen contraindicaciones para el examen de PAP; se debe evitar su toma cuando la usuaria tenga las siguientes condiciones:

- Sangrado menstrual.
- Ducha vaginal en las 72 horas previas.
- Medicamentos por vía vaginal durante la semana anterior.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 6 de 25

- Relaciones sexuales las 24 horas previas.
- Si ha sido sometida a exploración bimanual, o manipulaciones sobre el cuello (legrados, inserción o extracción de DIU), dentro de las últimas 48 horas.
- En las mujeres post aborto o post parto, se puede tomar el examen posterior a 6 semanas.

En aquellas mujeres que tengan alguna característica anterior, pero que según criterio del profesional sea imprescindible la toma de PAP, se deberá proceder a la toma independiente de las condiciones mencionadas anteriormente: Ej. mujeres de extrema ruralidad, baja adherencia a la toma del examen, PAP nunca, PAP atrasado, lesión sospechosa en el cuello uterino u otra zona, entre otras.

*** Única condición absoluta para la no toma: sangrado menstrual.**

1.2. Material y equipos.

- Espátula de Ayre
- Porta objetos con borde esmerilado
- Fijador citocelular
- Espéculo
- Camilla ginecológica con sabanilla o papel en su superficie
- Biombo
- Fuente lumínica (lámpara con ampolleta)
- Hoja de solicitud de examen citológico (SEC)
- Lápiz grafito

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 7 de 25

2. ETAPA PREANALÍTICA

2.1. Rotulación

La Matrona/ón identifica el portaobjeto con las iniciales del primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido y fecha de nacimiento de la usuaria.

2.2. Técnica para la obtención de la muestra

La usuaria se debe ubicar en posición ginecológica, con una adecuada fuente lumínica que permita visualizar el conducto vaginal y el cuello.

Utilización de guantes clínicos en ambas manos.

Colocación del espéculo vaginal “sin lubricante”. Si es necesario lubricar se puede utilizar agua destilada o solución salina.

El paso más importante para un buen examen es “visualizar” el cuello y el orificio exocervical.

En caso de exceso de moco, exudados purulentos o sangre que no permitan visualizar el orificio cervical externo limpiar mediante toques aplicados con una gasa humedecida con agua destilada o solución salina antes de tomar la muestra.

2.2.1. Toma con “Espátula de Ayre”

La muestra de cuello uterino con espátula de Ayre modificada, se realiza en dos partes:

- 1) Muestra exocervical: Con el extremo ondeado de la espátula apoyada sobre el orificio externo, girando en 360° con presión ligera sobre el cuello.
- 2) Muestra endocervical: Con el extremo en punta de la espátula de Ayre. La espátula de Ayre se introduce con el extremo en punta, luego se hace girar solo una vez en 360°.

La muestra obtenida debe ser transferida de forma **inmediata** al portaobjetos.

2.2.2. Extendido de la muestra

El extendido debe ser realizado en forma uniforme y delgado evitando la superposición celular; con el fin de obtener una película delgada, que permita

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 8 de 25

una fijación adecuada. Ambas muestras, tanto exocervical como endocervical, deben ser extendidas horizontalmente en el portaobjetos, evitando la zona esmerilada. El paso de la espátula de Ayre sobre la lámina debe hacerse de una sola vez en forma continua.

2.2.3. Técnica de fijación de la muestra citológica

Se debe colocar la lámina de muestra a una distancia de 30 cm del instrumento de fijación (fijador citológico en aerosol) con la intención de crear una película protectora de las células, homogénea y delgada.

Se debe evitar el contacto entre varias láminas fijadas por riesgo de adherencia y transferencia de material de estudio.

Las láminas fijadas no requieren condiciones especiales de conservación (sólo protección de polvo, humedad, calor y frío extremo).

Luego de extraer la muestra, depositarla en el portaobjeto y fijarla con aerosol, se debe adjuntar a la Hoja SEC (anexo 1). La Matrona deposita la muestra y Hoja SEC en contenedor plástico con tapa hermética que se encuentra en la mesa de procedimiento.

3. PROCEDIMIENTO DE ENVÍO Y REGISTROS ASOCIADOS

3.1 Solicitud de examen Citológico y Muestras Citológicas.

Responsable del llenado: Matrona

Cada lámina debe tener una solicitud de estudio. La solicitud de estudio corresponde a la hoja SEC (anexo 1), en la que se debe completar:

- RUN.
- Apellido paterno.
- Apellido materno.
- Nombre.
- Procedencia.
- Fecha de nacimiento.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 9 de 25

- Número de teléfono.
- Fecha de toma de PAP.
- Hora de toma de examen.
- Antecedentes de PAP anterior.
- Referir si es una muestra GES o NO GES.
- Nombre del médico o matrona que toma el PAP (Nombre, apellidos, RUN).
- Descripción del cuello uterino.
- Fecha de última menstruación.

Todos los campos de la solicitud deben ser llenados, de otra forma serán rechazadas las muestras cuando esté faltante algún dato solicitado.

Las láminas deben ser adjuntadas a la hoja SEC mediante un clip en el extremo superior izquierdo de la hoja.

La solicitud de examen debe venir doblada a la mitad.

En el caso de CESFAM una vez que la muestra de PAP es tomada por profesional Matrona, se deja en mesa de procedimiento, para posteriormente ser retirada por TENS de apoyo Matronas, quien prepara el envío a la UAP del HRFRZ en el BOX matrona.

En el caso de Postas las muestras son tomadas en box matrona, se complementan con la hoja SEC y estas son almacenadas en cajas plásticas rotuladas como muestras citológicas, la cual matrona de Posta trae de forma personal a CESFAM en cada ronda donde se realizó la toma de PAP, entregándola a TENS de apoyo matronas de CESFAM para su resguardo y posterior ordenamiento para envío a HRFRZ.

3.2. Trazabilidad de las muestras de PAP

Los documentos que se han definido son:

3.2.1 Cuaderno de registro local (anexo 2)

Responsable del llenado: TENS de apoyo Matronas.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 10 de 25

TENS que apoya a matronas registra la siguiente información de los PAP tomados por profesional matrona/ón:

- N° correlativo
- Fecha toma PAP
- Nombre y apellidos
- Edad
- Antecedentes de PAP anterior
- Lugar: Corresponde al recinto de salud donde se tomó el PAP (CESFAM Peralillo, PSR Población, PSR Los Cardos, PSR Calleuque, EMR Rinconada de Molineros)
- Actividad donde se toma el PAP: Exclusiva de toma de PAP, Control Ginecológico, Control Paternidad Responsable, Morbilidad Ginecológica, Control Prenatal entre otras.
- Fecha de Nacimiento
- Resultado de PAP (Se registra al momento de recibir nómina desde HRFRZ con los resultados)

3.2.2 **Nómina de PAP y preparación de muestras para envío (anexo 3): Responsable TENS de apoyo Matronas.**

Para el envío es obligatorio completar el documento estándar que contiene la siguiente información:

- Número de nómina.
- Código de Comuna.
- Procedencia de la muestra.
- Fecha de envío.
- Número correlativo de cada usuaria.
- RUT.
- Apellido Paterno

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 11 de 25

- Apellido Materno.
- Nombres.
- Fecha: Correspondiente a la toma de PAP
- Hora: Correspondiente a la hora que se tomó el PAP
- GES/NO GES: Establece si la persona corresponde a una garantía GES.
- Nombre de profesional: Que realiza la toma de PAP
- Fecha de recepción UAP.
- Nombre y apellido de funcionario estafeta de APS.

Se debe realizar una nómina por localidad y cada una debe ser cuadruplicada en tamaño carta en 2 sobres separados, uno para PAP que son Garantía GES otro para PAP que no son garantía GES (NO GES):

Copia 1 y 2 de la nómina: documento para UAP (dentro del sobre)

Copia 3 de la nómina: documento para constatar recepción en UAP (pegada fuera de la caja)

Copia 4 de la nómina: documento para UAP que queda de respaldo en CESFAM, custodiado en box de TENS de apoyo matronas.

Ambos sobres (GES y NO GES) son enviados en una misma caja plástica, es así como las muestras deben estar dispuestas con su Hoja SEC estiradas o dobladas a la mitad quedando el portaobjeto en la parte superior en forma horizontal dentro de los sobres. A su vez los sobres deben ir dentro de una caja plástica.

Las muestras deben ser ordenadas, según listado de pacientes en nómina, de manera correlativa.

El registro en SIGGES de los exámenes tomados debe ser realizado en forma diaria por la digitadora del CESFAM activándose, de esta forma, la Garantía de tamizaje de Papanicolau (plazo de 30 días desde la toma de PAP hasta el informe de análisis por la UAP). Para coordinar este

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 12 de 25

proceso existe un planilla de registro interno estadístico compartido entre ambas unidades (Anexo 4)

3.3. TRASLADO DE LA MUESTRA Y REGISTROS ASOCIADOS

3.3.1 Traslado de las muestras desde BOX TENS de apoyo Matrona a Unidad de Movilización CESFAM.

Responsable: TENS de apoyo Matrona.

Las muestras ya dispuestas para el envío a la UAP del HRFRZ se entregan a Jefe de movilización, quedando registro de entrega en Cuaderno de Registro de Envío de PAP (anexo 5). Contiene los siguientes datos:

- Fecha de entrega.
- N° de nómina (orden correlativo).
- Cantidad de PAP.
- Nombre y apellidos Encargado de Movilización.
- Firma.

3.3.2 Traslado de las muestras desde CESFAM a Unidad de Anatomía Patológica del HRFRZ

Responsable: Conductor/estafeta.

El traslado de las muestras será realizado de forma exclusiva por personal del CESFAM designado por Jefe de Movilización y se realizará como mínimo una vez a la semana, priorizando la entrega de las muestras de PAP en la UAP del HRFRZ sobre otras actividades encomendadas.

La recepción en la Unidad de Anatomía Patológica del HRFRZ se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

Al ser recepcionadas en UAP, la persona que los recibe debe firmar copia de nómina recepcionada (copia 3 del anexo 3) al funcionario estafeta, quien en su retorno debe pasar este registro a TENS de apoyo matrona, quien procede a archivarlo en su box.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 13 de 25

4. CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS

4.1. Criterios de rechazo de muestras en recepción UAP:

- Cotejo de número total no concordante (Devolución total).
- Solicitud sin lámina y/o lámina sin solicitud (Devolución total).
- Toda lámina quebrada sin posibilidad o seguridad de recuperación (Devolución total).
- No coincidencia de identificación entre lámina y solicitud. Deben coincidir las tres iniciales en el orden establecido. (Devolución total).
- Lámina sin esmeril. (Devolución total).
- Toda muestra que utilice papel, cinta adhesiva u otro elemento para rotular el portaobjeto o cualquier otro tipo de identificación a la lámina que no sea el descrito. (Devolución total).
- Una solicitud para dos o más láminas. (Devolución total). Excepto útero bicornue
- SEC incompletas, ilegibles o escritas con lápiz grafito.
- Muestra que no cumple con condiciones de transporte.

Si una muestra es rechazada será devuelta la totalidad de muestras al CESFAM con el conductor/estafeta.

5. FASE ANALÍTICA

Esta es realizada por la Unidad de Anatomía Patológica del HRFRZ.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 14 de 25

6. FASE POSTANALITICA

6.1 Recepción de los informes de resultados de PAP desde HRFRZ a CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Registros.

Los resultados son enviados desde de la UAP HRFRZ a través de Conductor/Estafeta del CESFAM (designado por el Jefe de movilización). Esta persona entrega Informe de los resultados (anexo 6) a TENS de apoyo Matrona, firmando en el mismo documento su entrega. TENS de apoyo Matrona entrega a Matrona Encargada del Programa Ca Cu tal informe donde deberá registrar el número de nómina de envío correspondiente y fecha de recepción, verificando que sea correcta la información y coincidan los datos y cantidad de PAP enviados a analizar.

Luego de esto, verificará los resultados destacados con un asterisco (*), el cual aparecerá en las siguientes situaciones:

- PAP positivo (Adenocarcinomas, NIE I hasta II, entre otros)
- PAP atípico, en cualquiera de sus categorías (excepto los PAP con resultado H1 que solo por 2da vez será marcado con asterisco)
- PAP inadecuado (escaso, hemorrágico, mal fijado, entre otros)
- PAP negativos con error de datos de filiación (datos no coincidentes)

La Matrona Encargada de Programa Ca Cu procederá a contactar a estos pacientes, a través de llamado telefónico o en su defecto citación en su domicilio y/o visita domiciliaria por profesional según corresponda, por diagnóstico y criterio médico, explicándoles el resultado del examen y con ello realizar las derivaciones o indicaciones según sea cada caso.

Los resultados serán registrados en formato digital (Anexo N°4) y kárdex (anexo 7), esto para el registro estadístico interno y mantener la información en línea con SIGGES CESFAM.

En el caso de exámenes con resultado alterado PAP positivo, Matrona Encargada Programa Ca Cu, será el responsable de registrar los resultados en la ficha electrónica e informar a usuaria.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 15 de 25

Todo resultado de PAP deberá quedar registrado en Ficha clínica de la usuaria del Establecimiento de origen e informado a usuaria. Este proceso podrá ser realizado por TENS de apoyo matrona y/o Matrona que realice sus funciones tanto en el sector urbano como rural.

6.2. Registro en SIGGES

Una vez que la Matrona y TENS realizan llamados a las usuarias para notificar los resultados de PAP, la TENS de apoyo Matrona remite los resultados de los exámenes (copia del anexo 6) a la digitadora SIGGES de CESFAM, quien deberá proceder al cierre de caso en dicha plataforma o, si procede, su derivación para confirmación en el nivel secundario. La nómina de resultados de exámenes originales queda en Box de TENS de Apoyo de Matrona para su custodia en carpeta Resultados de PAP.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 16 de 25

VIII. INDICADOR.

El procedimiento que se describe será evaluado en Box TENS de Apoyo Matronas de CESFAM:

Título	Proporción de solicitudes de examen citológico que contienen los datos mínimos según procedimientos establecidos en protocolo vigente.
Propósito	Evaluar la completitud de las solicitudes de examen citológico según procedimiento con el objetivo de disminuir el riesgo de eventos adversos asociados a omisión de los datos requeridos.
Tipo	Proceso.
Fórmula de cálculo	(Número de solicitudes de examen citológico evaluadas que contienen los datos mínimos según procedimiento establecido en el protocolo vigente en el trimestre/ Total solicitudes de examen citológico evaluadas en el trimestre)x100.
Fuente de datos	Solicitud hoja SEC. Pauta de cotejo de datos mínimos de solicitudes de examen citológico.
Umbral	Mayor igual a 90%.
Periodicidad de evaluación	Trimestral
Metodología de selección de casos.	En base a calculadora muestral de SIS- escenario 1, considerando un total estimado de las solicitudes de estudio anatomo patológico realizadas en un semestre (600) y la proporción esperada de cumplimiento de un 90% con un margen de error del 5% se calcula tamaño muestral semestral

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 17 de 25

	de 113 casos. Considerando que la periodicidad será cada 3 meses, los casos totales a evaluar en este tiempo serán de 57. Se seleccionan aleatoriamente las solicitudes para aplicación de la pauta de cotejo según número de caso establecido en las nóminas semanales (Anexo 8)
Responsables	Encargado de Calidad.
Observaciones	

IX. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y seguridad del usuario.
- Equipos de Matronas de CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas de Salud Rurales.
- TENS de Box Maternal de CESFAM Dr. Orlando Leyton A y TENS Postas de Salud Rurales.
- Jefe de Movilización y conductores CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Estafetas CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Equipo SIGGES CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Lehue V, Eugenia. Buscaglia F, Felipe. Manual para manejo de muestra citológica de Papanicolau en la red de establecimiento del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins.

XI. AUTORES

Saravia Neira Daniela, Matrona Sector Urbano CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

Cáceres Pérez Catherine, TENS Box Maternal CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 18 de 25

XII. CONTROL DE CAMBIOS

Cambios	Fecha de cambios	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)
Se incorpora indicador para APA 1.8 con pauta de cotejo	30-4-2026	Nataly Cortés F.  Nataly Cortés Farfán MATRONA RUT: 16.214.026-4	Cristian Cárdenas E, Director  

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 21 de 25

Anexo 3: Nómina de PAP enviado a UAP HRFRZ.

UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

NOMINA N° 17

CODIGO: 313
PROCEDENCIA: CESFAM PERALILLO
FECHA DE ENVÍO: 30/04/2026

N°	RUT	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA	HORA	GES/ NO GES	NOMBRE PROFESIONAL
1							NO GES	
2							NO GES	
3							NO GES	
4							NO GES	
5							NO GES	
6							NO GES	
7							NO GES	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FECHA DE RECEPCIÓN UAP: _____
Nombre y Apellido Funcionario Estafeta APS: Mauricio León León.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 22 de 25

Anexo 4: Nómina de PAP digital compartida con digitadoras SIGGES CESFAM.

UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

NOMINA N° 17

CODIGO: 313
PROCEDENCIA: CESFAM PERALILLO
FECHA DE ENVÍO: 30/04/2026

ANEXO N°4

N°	RUT	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA	HORA	GES/ NO GES	NOMBRE PROFESIONAL	LUGAR	N° TELEFONO	FECHA DE LLAMADO	HORA DE LLAMADO	FOLIO	CODIGO DE CIERRE
1							GES							
2							GES							
3							GES							
4							GES							
5							GES							
6							GES							
7							GES							
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														

FECHA DE RECEPCIÓN UAP: _____
Nombre y Apellido Funcionario Estafeta APS: Mauricio León León.

	PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA, ROTULACIÓN, REGISTROS, TRASLADO Y RECEPCIÓN DE PAPANICOLAOU	Código:	GCL 1.8 / APA 1.2
		Fecha:	Abril de 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Abril de 2031
		Página:	Página 24 de 25

Anexo 6: Informe de resultados

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA

CONSULTORIO PERALILLO

Nº 14

Fecha: 28 JUN. 2019

Recepción: Srta. Cecilia

R.U.T.	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	F. Examen	Diagnosticos
				10/05/2019 I	G7 J1 ✓
				11/05/2019 I	J1 G8 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				11/05/2019 I	G8 ✓
				11/05/2019*G1	(Repetir) ✓
				11/05/2019 I	G7 J1 ✓
				11/05/2019 I	G8 ✓
				11/05/2019 I	J1 G8 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				11/05/2019 I	J1 G8 ✓
				11/05/2019 I	G8 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				11/05/2019 I	G7 ✓
				13/05/2019 I	G8 ✓
				14/05/2019 I	G7 ✓
				14/05/2019*G1 T1	(Repetir) devoción ✓
				15/05/2019 I	J1 G8 ✓
				15/05/2019 I	G7 ✓
				15/05/2019*G3	(Repetir) ✓
				16/05/2019 I	G8 ✓
				16/05/2019*G3	(Repetir) ✓

23

Nataly Cortés Farfán
MATRONA
RUT: 16.714.026-4

I = Negativo para células neoplásicas. Muestra satisfactoria
* = Ver informe anexo
J = Reacc. Infl. 1) Inesp. 2) Trich. 3) Herpes 5) Candida 6) Actinomyces
F1 = Frotis atrofico
O = Tratar Condiciones Locales y Repetir 3) en 6 meses ; 5) en 3 meses
G7 = Muestra poco satisfactoria. No se observan células endocervicales ni metaplasias
G8 = Muestra Satisfactoria
S = Se sugiere control en un año

Informe extraordinario solicitado por el consultorio
Total de exámenes : 23
Fecha de recepción : 17/05/2019

Dr. F. Buscaglia F.
Fecha de informe : 20/06/2019

